

晩発性皮質性小脳萎縮症

— MSA-C鑑別・除外ワークアップ・難病申請 —

成人の孤発性小脳失調症をエビデンスで読み解く。

医療従事者向け | 2026年9月確認

純粋小脳型と二次性除外の重要性。

高齢者の緩徐進行性運動失調で、
まず何を考えるべきでしょうか？

診療の原則

MSA-Cや二次性失調を網羅的に除外し、
Probable SCDとして支援を組み立てます。

3つの視点から臨床実務を整理します。

1

病態とMSA-C鑑別

純粋小脳型と多系統変性の決定的な違い。

2

除外ワークアップ

見逃してはならない治療可能疾患の検索。

3

難病申請と管理

個人票の要点・リハビリのエビデンス。

進行速度と多系統病変の有無で峻別する。

晩発性皮質性小脳萎縮症 (LCCA)

極めて緩徐進行
純粋小脳失調症。

VS

多系統萎縮症・小脳型 (MSA-C)

比較的急速進行
起立性低血圧・排尿障害。
パーキンソニズム高頻度。

初期症状が似ていても予後は大きく異なります。

MSA-Cを示唆する4つのサイン。

- 高度自律神経障害

起立性低血圧・残尿・尿失禁。

- 錐体外路症状

筋強剛・無動・姿勢反射障害。

- 睡眠時呼吸障害

夜間吸気性喘鳴・睡眠時無呼吸。

- 画像サイン

橋十字サイン・中小脳脚高信号。

発症初期に症状が揃わなくても定期評価を継続します。

治療可能な二次性失調を検索。

領域	検査項目	除外対象
栄養代謝	B1・B12・TSH	Wernicke・甲状腺
自己免疫	抗GAD・抗核抗体	抗GAD小脳炎等
傍腫瘍性	抗体・胸腹部CT	傍腫瘍性小脳変性
感染中毒	梅毒・フェニトイン	神経梅毒・薬剤性

治る失調症を確実に鑑別します。

孤発例に見える優性SCD。

家族歴陰性でも否定できない病型。

注意病型

SCA6・SCA31（高齢純粋小脳型）。

対応方針

カウンセリングの上でパネル検査。

発症の遅さ等で孤発に見える例あり。

家族歴なしでも申請可能。

よくある誤解

遺伝子や病理の
確定診断がなければ
難病申請できない。

制度上の真実

孤発例はProbable認定。
二次性除外のSCDとして
告示18の対象となります。

個人票に緩徐進行と除外を明記。

国内SCDの大半は孤発性。

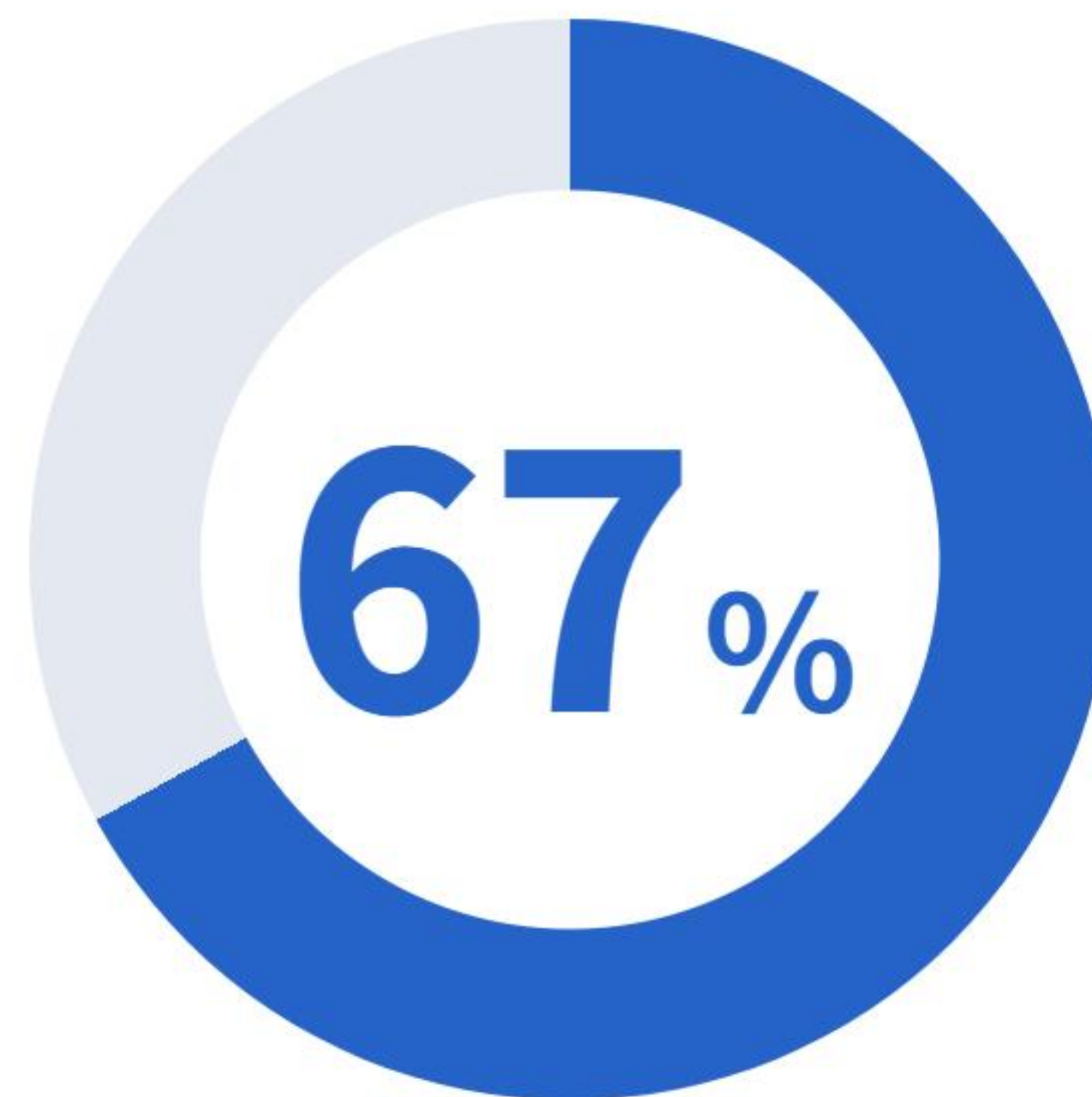
国内疫学

孤発例割合

国内SCD患者の約3分の2は
孤発例

家族歴がなくてもSCDを疑う

LCCAもこの孤発群に含まれます。



生活機能を支える3つの柱。

1 リハビリ継続

機能維持

歩行・バランスと
構音嚥下訓練。

2 環境・制度

転倒予防

介護保険申請と
手すり・歩行車。

3 対症療法

合併症管理

TRH誘導体や
誤嚥性肺炎予防。

多職種連携で患者と家族の生活を支えます。

LCCA診療の3大鉄則。

鉄則1

純粋小脳型の確認
MSA-Cや二次性を
徹底除外。

鉄則2

難病申請の要件
告示18・mRS3以
上等を評価。

鉄則3

集中的リハビリ
運動機能とADLの維持
に有効。

早期の環境整備と連携が生活を支えます。

臨床における留意事項

**この動画は一般的な情報提供であり、
診断・治療の代わりにはなりません。
症状がある場合は医療機関を受診してください。**

本動画は医療従事者向けの医学教育・情報提供を目的としています。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

本日の要点

LCCAは純粋小脳型。
リハビリが要。

参考文献

詳しい文献は、
概要欄の記事へ。

次回予告

最新エビデンスを
お届けします。

※個々の治療方針は担当医の判断によります。